

RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

Anna Farrés Rabanal, Pablo López Martínez, Gonzalo Gutiérrez Carrillo, Marta Molina Bravo, Miguel García Sanz, Teresa Renedo Villar, Mateo Hevia Suarez, Mario De Arriba Alonso, Alejandro Sanz Ruiz, Miguel Ángel Alonso Prieto, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La retención aguda de orina (RAO) consiste en la imposibilidad o dificultad para realizar la micción espontánea, de forma brusca y generalmente dolorosa, a pesar del deseo del paciente. Es junto con la hematuria la urgencia urológica más frecuente. Aunque se puede presentar en cualquier momento, su frecuencia aumenta con la edad, siendo más frecuente a partir de la sexta década de la vida. Además, es más habitual que se presente en hombres.

Etiología

- Causa obstructiva (mecánica): Hipertrofia prostática (la causa más frecuente), neoplasia de próstata, neoplasia vesical, fimosis, parafimosis, estenosis uretral, prolapso de órganos pélvicos, neoplasia ginecológica, fibromas uterinos, litiasis vesicales.
- Causa infecciosa y/o inflamatoria: Prostatitis, balanitis, uretritis, vulvovaginitis, cistitis.
Sobredistensión vesical: Estreñimiento, inmovilidad prolongada (posquirúrgica, por ejemplo), ingesta excesiva de líquidos.
- Causa neurológica (vejiga neurógena): ACV, esclerosis múltiple, hidrocefalia, enfermedad de Parkinson, mielitis transversa, poliomielitis, tumores del cono medular o la cauda equina.
- Causa farmacológica: Antiarrítmicos, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, relajantes musculares, antiparkinsonianos, antihipertensivos.
- Miscelánea: traumatismos previos, causa psicógena.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis.

Antecedentes personales sintomatología del tracto urinario inferior (prostatismo), hematuria, infección urinaria, sondaje vesical, cáncer de próstata o vejiga, retención aguda de orina previa, traumatismo pélvico.

Tratamiento farmacológico que realiza.

Presencia de imposibilidad para la micción, de inicio súbito y, habitualmente, con dolor abdominal en la región suprapúbica.

Exploración física.

Exploración general.

Exploración abdominal que permita valorar la presencia de globo vesical.

Tacto rectal que permita constatar la presencia de masas, impactación fecal, dolor perineal y valorar el tamaño prostático.

Evaluación pélvica en mujeres.

Exploración neurológica para descartar lesión central, periférica o medular.

Exámenes complementarios

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, PCR.
- Coagulación básica si paciente toma ACOs.
- Sistemático y sedimento de orina.

- Ecografía abdominal. Aunque no está indicada de forma rutinaria, se solicitará en caso de duda diagnóstica.
- Urocultivo si fiebre.
- Rx de abdomen simple.

TRATAMIENTO

Medidas generales

- Control de constantes vitales.
- **Colocación de sonda vesical:** si no es posible el sondaje, sin forzar, se realizará interconsulta a Urología.
 - Se realizará el procedimiento cumpliendo con las medidas de asepsia y antisepsia.
 - Lubricación uretral abundante.
 - Inicialmente se intentará la cateterización uretral con una sonda de un calibre entre 14-16 Ch de tipo Foley y de silicona. Si el paciente tiene antecedente de resección transuretral (RTU) o estenosis de uretra se utilizará una sonda de menor calibre (10-12 Ch). Por el contrario, si se sospecha obstrucción prostática (por hipertrofia) se debe utilizar una sonda de mayor calibre (18-20 Ch) y, preferiblemente, acodada.
 - Tras acabar el procedimiento se asegurará la correcta colocación del prepucio para evitar parafimosis.
 - Tras el sondaje, se cuantificará y se reflejará en el informe clínico el total de orina evacuado. Después del procedimiento puede presentarse poliuria desobstructiva, hematuria ex vacuo o hipotensión, que en raras ocasiones tienen repercusión clínica.
- **Colocación de talla vesical (cistostomía):** si no es posible la cateterización uretral. Este procedimiento lo indicará y realizará el urólogo. Es necesario un kit de cateterismo suprapúbico, con catéter Foley de silicona 12 Ch, una ampolla de anestésico local, una jeringa de 10 mL para cargar la anestesia y una aguja de punción lumbar 20-25 G. Se realiza con el paciente en decúbito supino y en ocasiones puede ser necesario realizar el procedimiento bajo control ecográfico.

Medidas específicas

- Mantener el sondaje vesical durante al menos 3 días y retirar en su centro de salud con control y seguimiento por urólogo de referencia.
- Si se sospecha de hiperplasia prostática y el paciente no está en tratamiento, se debe indicar un alfa-bloqueante (silodosina 8 mg/24 h o tamsulosina 0,4 mg/24 h). Si ya estuviera en tratamiento podría añadirse un inhibidor de la 5 alfa-reductasa (finasterida 5 mg/24 h o dutasterida 0,5 mg/24 h).
- En caso de antecedente previo de RAO, insuficiencia renal agudo secundario o volumen de retención > 1L, no indicar retirada del sondaje y derivar directamente al urólogo de referencia.
- El tratamiento antibiótico se indicará en caso de infección urinaria asociada.
- Se valorará ingreso por urología en caso de insuficiencia renal aguda, hematuria ex vacuo con repercusión clínica o infección urinaria complicada asociada.

BIBLIOGRAFÍA.

- Grise S. Retenciones urinarias agudas completas. En: Lenoble M, Horay P. Enciclopedia Médico Quirúrgica. Urología. Editions Scientifiques et Médicales Elsevier. Paris: 18-207-D-20. 2002.

- Lledo E., Durán R., Escribano G., Sanz A.: Retención urinaria aguda en: Urgencias Urológicas. Tema Monográfico LXI Congreso Nacional de la A.E.U. 1996: 197-210.
- Parrilla Ruiz FM, Aguilar Cruz I, Cárdenas Cruz D, Cárdenas Cruz A. Manejo urgente de la retención aguda de orina en hombres. Aten Primaria. [Internet.] 2013;45:498-500. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2013.03.001>
- PD Yoon, V Chalasani, HH Woo. Systematic review and meta-analysis on management of acute urinary retention. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015;18:297-302.
- Rodríguez García, M. and Fernández-Samos Gutiérrez, R. (2014). Criterios de actuación en Urgencias León. [León]: Complejo Asistencial Universitario de León, pp.221-222.